



GESTIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL EN COLOMBIA

# Resolución 2646 de 2008 y Resolución 2404 de 2019

*Factor de riesgo psicosocial en el trabajo: del marco normativo a los instrumentos técnicos de evaluación e intervención*

---

**GRUPO 2 · Riesgos Laborales**

Laura Alejandra García Mora

Sara Valentina Robayo Riaño

11 de agosto de 2026

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

# CONTENIDO



## Introducción y contexto

01

Por qué existe la normativa de riesgo psicosocial en Colombia



## Resolución 2646 de 2008

02

Marco normativo: identificación, evaluación, intervención



## El vínculo entre ambas normas

03

De la obligación legal a la herramienta técnica



## Resolución 2404 de 2019

04

Batería de instrumentos, guía técnica y protocolos



## Casos reales y actividad

05

Aplicación práctica y ejercicio grupal



## Referencias y preguntas

06

Fuentes oficiales y espacio de discusión

# ¿Por qué hablar de riesgo psicosocial?

El estrés laboral es, desde 1994, una enfermedad profesional reconocida en Colombia (Decreto 1832 de 1994). La evidencia nacional muestra que la exposición a factores psicosociales es generalizada en el mundo del trabajo:

### 2 de 3

trabajadores manifestaron estar expuestos a factores psicosociales durante su última jornada laboral completa

### 20%–33%

de los trabajadores encuestados reportó sentir altos niveles de estrés

*Fuente: Encuestas Nacionales de Condiciones de Salud y Trabajo (2007 y 2013), Ministerio del Trabajo — citadas en los considerandos de la Resolución 2404 de 2019*



### El reto normativo

**Ley 1616 de 2013 (art. 9°):** obliga a las ARL a promover la salud mental y a garantizar el monitoreo permanente de la exposición a riesgo psicosocial.

**El vacío:** muchas empresas evaluaban el riesgo con instrumentos no validados en el país, sin lineamientos unificados de intervención.

# Objeto y ámbito de aplicación



## Objeto (Art. 1°)

*Establecer disposiciones y responsabilidades para:*

- ♦ Identificación
- ♦ Evaluación
- ♦ Prevención
- ♦ Intervención
- ♦ Monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial
- ♦ Determinación del origen de patologías por estrés ocupacional



## Ámbito de aplicación (Art. 2°)

- ♦ Empleadores públicos y privados
- ♦ Trabajadores dependientes e independientes
- ♦ Contratantes bajo contrato civil, comercial o administrativo
- ♦ Organizaciones de economía solidaria y sector cooperativo
- ♦ Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP)
- ♦ Policía Nacional (personal no uniformado) y personal civil de las Fuerzas Militares

# Definiciones clave



## Riesgo

Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado.



## Factor de riesgo

Posible causa o condición responsable de la enfermedad, lesión o daño.



## Factores psicosociales

Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.



## Factor protector psicosocial

Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar del trabajador.



## Estrés

Respuesta fisiológica, psicológica y conductual del trabajador al intentar adaptarse a las demandas de sus condiciones laborales y extralaborales.



## Carga de trabajo

Tensión resultante de la convergencia de las cargas física, mental y emocional.

# Factores psicosociales intralaborales

*Aspectos mínimos que todo empleador debe identificar y evaluar dentro de la organización:*



- a Gestión organizacional (estilo de mando, contratación, capacitación, bienestar)
- b Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, demandas)
- c Características del grupo social de trabajo (clima, cohesión, trabajo en equipo)
- d Condiciones de la tarea (carga mental, responsabilidad, demandas emocionales)
- e Carga física (postura, fuerza, movimiento y traslado de cargas)
- f Condiciones del medioambiente de trabajo (ruido, iluminación, temperatura)
- g Interfase persona–tarea (conocimientos, habilidades, autonomía)
- h Jornada de trabajo (duración, pausas, turnos, horas extra)

# Factores extralaborales e individuales



## Extralaborales (Art. 7°)

- ✦ Utilización del tiempo libre (recreación, deporte, otros trabajos)
- ✦ Tiempo de desplazamiento y medio de transporte casa–trabajo
- ✦ Pertenencia a redes de apoyo social (familia, comunidad)
- ✦ Características de la vivienda (estrato, servicios, acceso a vías)
- ✦ Acceso a servicios de salud



## Individuales (Art. 8°)

- ✦ Información sociodemográfica (sexo, edad, escolaridad, cargo, antigüedad)
- ✦ Características de personalidad y estilos de afrontamiento (instrumentos psicométricos)
- ✦ Condiciones de salud (exámenes médicos ocupacionales)

*Con esta información se debe realizar un análisis epidemiológico que permita determinar los perfiles de riesgo–protección por área de la empresa (Art. 8°, Parágrafo).*

# Evaluación, instrumentos y reserva de la información



## Efectos evaluados en el trabajador y en la empresa (Art. 9°)

Condiciones de salud por sistema corporal

Accidentalidad y enfermedad profesional

Ausentismo y rotación de personal

Rendimiento laboral

**Instrumentos (Art. 10°):** deben ser objetivos y subjetivos, validados en el país.

**Seguimiento (Art. 12°):** actualización anual, discriminada por actividad económica, número de trabajadores, ocupación, sexo y edad; disponible para el Ministerio del Trabajo y las ARL.



## Reserva de la información (Art. 11°)

La información está sometida a reserva conforme a la Ley 1090 de 2006.

Los expertos deben garantizar por escrito el uso exclusivo de la información para fines de salud ocupacional.

La evaluación requiere consentimiento informado previo del trabajador.

# Criterios para la intervención de los factores psicosociales

1

## Compromiso institucional

Implica el compromiso de la gerencia o dirección y de los trabajadores.

2

## Participación

Se debe establecer con la participación de los directamente interesados o afectados.

3

## Priorización técnica

Según asociación estadística con efectos negativos y recomendaciones de la literatura científica.

4

## Educación continua

Actividades formativas paralelas a la modificación de las condiciones de trabajo.

5

## Enfoque interdisciplinario

Debe primar el trabajo conjunto de distintas disciplinas.

6

## Atención a crisis

Para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención en crisis.

# Prevención y corrección del acoso laboral



## Medidas preventivas

- ♦ Formular una política clara contra el acoso laboral
- ♦ Elaborar códigos o manuales de convivencia
- ♦ Sensibilizar sobre el acoso laboral y sus consecuencias
- ♦ Capacitar en resolución de conflictos y negociación
- ♦ Conformar el Comité de Convivencia Laboral
- ♦ Establecer un procedimiento confidencial para la queja



## Medidas correctivas

- ♦ Intervenir los factores de riesgo priorizados, fomentando la no violencia
- ♦ Promover la participación de los trabajadores en las estrategias de intervención
- ♦ Facilitar el traslado del trabajador cuando lo recomiende el médico tratante o el Comité
- ♦ Establecer un procedimiento confidencial y conciliatorio para corregir el acoso

# Determinación del origen de patologías y sanciones



## Determinación del origen (Art. 18°–20°)

- Se parte de las patologías incluidas en la Tabla de Enfermedades Profesionales.
- Para patologías no incluidas, se acude al Decreto 1832 de 1994.
- También se puede acudir a la OIT, la OMS, la OPS y publicaciones científicas reconocidas.
- Se aplica el Protocolo para la Determinación del Origen de las Patologías Derivadas del Estrés, actualizado como mínimo cada 4 años (Art. 19°).
- El empleador aporta la información de exposición y vigilancia epidemiológica; la ARL aporta su información disponible (Art. 20°).



## Sanciones (Art. 21°)

El incumplimiento se sanciona conforme a los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994.

La investigación administrativa y la sanción son competencia de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo).

# De la obligación legal a la herramienta técnica

2008

## Resolución 2646

Crea la obligación de evaluar el riesgo psicosocial con "instrumentos validados en el país" (Art. 10º) — pero aún no existían instrumentos oficiales unificados.

2013

## Ley 1616 de Salud Mental

Exige a las ARL garantizar el monitoreo permanente de la exposición a riesgo psicosocial (Art. 9º).

2009–2010

## Investigación del Ministerio

Se diseña y valida en Colombia una batería de instrumentos en una muestra de trabajadores afiliados al sistema de riesgos.

2019

## Resolución 2404

Adopta oficialmente la Batería de Instrumentos, la Guía Técnica General y 15 Protocolos Específicos como referentes técnicos obligatorios.

# Objeto y ámbito de aplicación



## Objeto (Art. 1°)

*Adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios:*

- ♦ Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial
- ♦ Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención
- ♦ 15 Protocolos Específicos de actuación

*Uso gratuito, de libre acceso y de obligatorio cumplimiento para los usuarios (Art. 2°, Parágrafo).*



## Ámbito de aplicación (Art. 2°)

*Retoma el ámbito de la Resolución 2646 y lo amplía a:*

- ♦ **Empresas de servicios temporales**
- ♦ **Estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales**
- ♦ **Trabajadores en misión**

*(Además de empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, economía solidaria, agremiaciones, Policía y Fuerzas Militares, ya previstos en la Res. 2646).*

# Batería de instrumentos para la evaluación



## 1. Cuestionario intralaboral

Evalúa los factores de riesgo psicosocial dentro de la organización



## 2. Cuestionario extralaboral

Evalúa las condiciones fuera del entorno de trabajo



## 3. Cuestionario de estrés

Mide el nivel de estrés percibido por el trabajador



## 4. Ficha de datos generales

Recoge información sociodemográfica y ocupacional

*Los cuestionarios deben aplicarse garantizando reserva y confidencialidad, siguiendo los manuales del usuario. No pueden modificarse en forma ni en fondo, pues afectaría su validez y confiabilidad.*



**Guías de análisis psicosocial (a profundidad):** guía para el análisis de puestos de trabajo, guía de entrevistas semiestructuradas y guía de grupos focales.

# Guía técnica general y protocolos específicos



15 instrumentos en total (Art. 1°): la Batería, la Guía Técnica General y 13 protocolos específicos, entre ellos:



## Protocolos por efecto en la salud

- ♦ Acoso psicológico / acoso laboral
- ♦ Síndrome de agotamiento laboral ("Burn-out")
- ♦ Depresión
- ♦ Trastorno de estrés postraumático
- ♦ Reacción a estrés agudo
- ♦ Situaciones de duelo



## Protocolos por actividad económica

- ♦ Administración pública
- ♦ Sector Defensa
- ♦ Salud y asistencia social
- ♦ Sector transporte
- ♦ Sector educativo
- ♦ Sector financiero

# Periodicidad de la evaluación y custodia de la información



## Periodicidad (Art. 3°)

### Riesgo ALTO

Evaluación ANUAL, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales.

### Riesgo MEDIO o BAJO

Acciones preventivas y correctivas y, una vez implementadas, seguimiento cada DOS años (mínimo), para mantener información actualizada.



## Custodia de los instrumentos (Art. 5°)

**IPS contratada por el empleador:** custodia el instrumento e integra la historia clínica ocupacional.

**Psicólogos especializados (internos o externos):** tienen la guarda y custodia, garantizando confidencialidad.

**Prohibición:** en ningún caso el empleador o contratante puede tener, conservar o anexar copia de los instrumentos ni de la historia clínica ocupacional en la hoja de vida del trabajador (Parágrafo).

# Cómo se conectan la Resolución 2646 y la Resolución 2404

**2008**

## Resolución 2646

### EL QUÉ

Define el marco normativo: qué se debe identificar, evaluar, intervenir y monitorear frente al riesgo psicosocial, y ordena usar "instrumentos validados en el país" (Art. 10°).



**2019**

## Resolución 2404

### EL CÓMO

Provee esos instrumentos: la Batería validada, la Guía Técnica y 15 protocolos, cerrando el vacío técnico que dejó abierto la 2646 (ver considerandos de la 2404).

*La Resolución 2646 obliga; la Resolución 2404 estandariza cómo cumplir esa obligación en todo el territorio nacional.*

# Ejemplos de aplicación en entornos laborales reales



## Sector salud: fatiga y burnout

Un hospital identifica alta rotación y ausentismo en personal de enfermería tras jornadas extensas y turnos nocturnos (factor intralaboral: jornada de trabajo, Art. 6° h).

Aplica la Batería de Instrumentos (2404) y activa el Protocolo de intervención para trabajadores de la salud – Gestión de demandas en el trabajo, junto con el protocolo de "Burn-out".

---

*Resultado: al ser riesgo alto, la evaluación pasa a periodicidad anual (Art. 3° Res. 2404) dentro del sistema de vigilancia epidemiológica.*



## Centro de contacto: acoso laboral

Trabajadores de un call center reportan presión constante de un jefe inmediato, con comentarios humillantes ante el equipo (Art. 3° I, Ley 1010 de 2006, citada en la Res. 2646).

El Comité de Convivencia Laboral (Art. 14°, Res. 2646) activa el procedimiento interno confidencial y conciliatorio; se evalúa traslado del trabajador si lo recomienda el médico tratante.

---

*Resultado: se documenta con el Protocolo de prevención y actuación – Acoso laboral (numeral 10, Res. 2404), preservando la reserva de la información.*

## CASO REAL

# Formulación del plan de prevención de riesgo psicosocial en una empresa del sector de servicios de reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos en la ciudad de Bogotá

**Caso:** Este estudio analiza una empresa real de mantenimiento de maquinaria en Bogotá. Con base en la Res. 2646/2008 (obligación legal) y la Res. 2404/2019 (aplicación de la Batería Oficial), evaluó al personal y halló riesgo alto y muy alto en la parte operativa por exceso de carga laboral, tiempos límite ajustados y estrés. Como solución, formuló un plan de intervención con rediseño de turnos, pausas psicosociales y gestión del estrés.



# Referencias y espacio de preguntas



## Análisis de caso: taller relámpago

**Caso:** En una empresa de logística, los conductores reportan jornadas extensas sin pausas claras, presión por tiempos de entrega y poca retroalimentación de sus jefes. En los últimos 6 meses ha aumentado el ausentismo y dos trabajadores han solicitado cambio de área.

En grupos de 3–4 personas, discutan (8 minutos):

- 1 ¿Qué factores intralaborales (Art. 6°, Res. 2646) identifican en el caso?
- 2 ¿Qué instrumentos de la Batería (Art. 4°, Res. 2404) aplicarían primero y por qué?
- 3 ¿Qué protocolo específico de la Res. 2404 activarían para intervenir?
- 4 Según el nivel de riesgo que definan, ¿cada cuánto debería repetirse la evaluación (Art. 3°, Res. 2404)?

¿Preguntas?



## Referencias

- ♦ Ministerio de la Protección Social. (2008). Resolución 2646 de 2008. Diario Oficial 47.059.
- ♦ Ministerio del Trabajo. (2019). Resolución 2404 de 2019.
- ♦ Congreso de la República. (2006). Ley 1010 de 2006, sobre acoso laboral.
- ♦ Congreso de la República. (2006). Ley 1090 de 2006, que reglamenta la profesión de psicología.
- ♦ Congreso de la República. (2013). Ley 1616 de 2013, de Salud Mental.
- ♦ Ministerio del Trabajo. Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial: [www.fondoriesgoslaborales.gov.co](http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co)
- ♦ Según Estupiñán López (2022), la aplicación de la batería de riesgo psicosocial...

*Gracias por su atención*

Laura Alejandra García Mora · Sara Valentina Robayo Riaño